

보건복지부 고시 제2025-129호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2025-102호(2025. 6. 26.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2025년 7월 28일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[119] Satralizumab 주사제(품명: 엔스프링프리필드시린지주), [142] Baricitinib 경구제(품명: 올루미언트정 2밀리그램 등), [142] Belimumab 주사제(품명: 벤리스타주 120밀리그램 등), [239] Migalastat 경구제(품명: 갈라폴드캡슐), [396] Empagliflozin 경구제(품명: 자디앙정 10밀리그램)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2025년 8월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 2]

[119] 기타의 중추신경용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[119] Satralizumab 주사제 (품명: 엔스프링프리필 드시린지주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 항아쿠아포린-4(AQP-4) 항체 양성인 만 18세 이상의 성인 시신경척수염 범주질환 환자로 다 음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) <u>최근 2년 이내 적어도 2번 (최근 1년 이내 1번 포함)의 증상 재발</u> 이 있는 경우로서, - Rituximab 주사제의 급여기준에 적합하여 3개월 이상 해당 약제를 투여하였음에도 증 상 재발이 있거나, 부작용으로 투여를 지속 할 수 없는 경우 2) Satralizumab 투여 시점에 확장 장애 상태	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 항아쿠아포린-4(AQP-4) 항체 양성인 만 18세 이상의 성인 시신경척수염 범주질환 환자로 다 음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) <u>최근 1년 이내 적어도 1번의 증상 재발</u> 이 있는 경우로서, - Rituximab 주사제의 급여기준에 적합하여 3개월 이상 해당 약제를 투여하였음에도 증 상 재발이 있거나, 부작용으로 투여를 지속 할 수 없는 경우 2) (현행과 같음)	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등 을 참조하여 투여대 상의 재발기준을 완 화함.

[119] 기타의 중추신경용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	척도 (Extended Disability Status Scale, EDSS) 점수 ≤ 6.5인 경우 (이하 생략)	(현행과 같음)	

※ 관련근거

1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e > Chapter 445: Neuromyelitis Optica
2. Clinical Neurology & Neuroanatomy: A Localization Based Approach, 2e > Chapter 21: Demyelinating Diseases of the Central Nervous System
3. Ferri's Clinical Advisor 2025 > 770.e15 Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
4. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) – revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long term management J. Neurol. 2024;271:141–176
5. International Delphi Consensus on the Management of AQP4-IgG+ NMOSD Recommendations for Eculizumab, Inebilizumab, and Satralizumab Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2023;10:e200124.
6. Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2023.
7. 多發性硬化症・視神釋脊髓炎 スペクトラム障害 診療ガイドライン 日本神経學會 2023
8. 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자. 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회). 2023.
9. S.J. Pittock et al, Ravulizumab in Aquaporin-4-Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, Ann Neurol 2023;93:1053–68.
10. S.J. Pittock et al, Eculizumab in Aquaporin-4-Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, N Engl J Med 2019;381:614–25.
11. T. Yamamura et al, Trial of Satralizumab in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, N Engl J Med 2019;381:2114–24.
12. A. Traboulsee et al, Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised,

[119] 기타의 중추신경용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	double-blind, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial Lancet Neurol 2020;19:402–12.		
	13. BA C Cree et al, Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOMentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial Lancet 2019;394:1352–63.		
	14. M Tahara et al, Safety and efficacy of rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorders (RIN-1 study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial Lancet Neurol 2020;19:298–306.		
	15. C Zhang et al, Safety and efficacy of tocilizumab versus azathioprine in highly relapsing neuromyelitis optica spectrum disorder (TANGO): an open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial Lancet Neurol 2020;19:391–401.		
	16. SL Clardy et al, Network Meta-analysis of Ravulizumab and Alternative Interventions for the Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder Neurol Ther 2024;13:535–49.		
	17. HL Lee et al, Results of a Survey on Diagnostic Procedures and Treatment Choices for Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder in Korea: Beyond the Context of Current Clinical Guidelines J Clin Neurol 2022;18(2):207–13.		
	18. CADTH Reimbursement Recommendation: Ravulizumab(Ultomiris)Indication: For the treatment of adult patients with anti-aquaporin 4 (AQP4) antibody-positive neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)(2024.4.)		
	19. CADTH Rituximab for the Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder(2021.2.)		
	20. Ontario Exceptional Access Program Reimbursement Criteria for Frequently Requested Drugs(2023.12.18.)		
	21. PHARMACEUTICAL BENEFITS ADVISORY COMMITTEE (PBAC) MEETING OUTCOMESNOVEMBER 2024 PBAC MEETING		
	22. PHARMACEUTICAL BENEFITS ADVISORY COMMITTEE (PBAC) MEETING OUTCOMESSEPTEMBER 2021 PBAC MEETING		

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Baricitinib 경구제 (품명: 올루미엔트정 2밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 성인 류마티스 관절염 환자 가. 투여대상 ACR/EULAR 진단기준(2010년 제정)에 부합하는 성인 류마티스 관절염 환자 중 다음 한 가지에 해당하고 두 가지 종류 이상(MTX(methotrexate) 포함)의 DMARDs(Disease Modifying AntiRheumatic Drugs)로 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였으나, 치료효과가 미흡하거나 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 환자(다만, MTX 사용이 불가능한, 간질환 또는 신부전 등의 경우에는 MTX를 제외한 두 종류 이상의 DMARDs 사용)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>1. 성인 류마티스 관절염</u> 가. 투여대상(<u>모두 만족</u>) <u>1) 진단: ACR/EULAR 진단기준(2010년 제정)에 따른</u> <u>2) 선행치료</u> <u>가) MTX(methotrexate)를 포함한 두 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 투여에도 효과가 미흡하거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우</u> <u>나) 상기 가)의 MTX 사용이 불가능한(간질환 또는 신부전 등) 경우에는 MTX를 제외한 두 종류 이</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상 연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, ‘소아 중증 아토피 피부염에 Baricitinib 경구제의 급여기준을 확대함. ○ 급여기준 가독성 향상을 위하여 ‘성인 류마티스 관절염’ 및 ‘만성 중증 아토피 피부염’ 관련 문구 및 용어 등을 정비함.

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	- 다만, 65세 이상 환자, 심혈관계 고위험군 환자, 악성 종양 위험이 있는 환자에서는 기존 치료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 함. - 다 음 - 1) DAS28이 5.1 초과 2) DAS28이 3.2 ~ 5.1이고 영상 검사 상 관절 손상의 진행이 있는 경우 ※ DAS28(Disease Activity Score in 28 joints) ◦ $DAS28(ESR) = 0.56 \times \sqrt{(TJC-28)} + 0.28 \times \sqrt{(SJC-28)} + 0.014 \times VAS + 0.70 \times \ln(ESR)$ ◦ $DAS28(CRP) = 0.56 \times \sqrt{(TJC-28)} + 0.28 \times \sqrt{(SJC-28)} + 0.014 \times VAS + 0.36 \times \ln(CRP+1) + 0.96$ TJC: 압통 관절수 SJC: 부종 관절수 VAS: 환자의 전반적인 상태보고	<u>상의 DMARDs 사용</u> <u>다) 단, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함.</u> <u>※ 질병조절 항류마티스제(Disease Modifying AntiRheumatic Drugs, DMARDs)</u> <u>3) 질병활성도</u> <u>가) DAS28이 5.1 초과</u> <u>나) DAS28이 3.2 ~ 5.1이고 영상 검사 상 관절 손상의 진행이 있는 경우</u> ※ DAS28(Disease Activity Score in 28 joints) ◦ $DAS28(ESR) = 0.56 \times \sqrt{(TJC-28)} + 0.28 \times \sqrt{(SJC-28)} + 0.014 \times VAS + 0.70 \times \ln(ESR)$ ◦ $DAS28(CRP) = 0.56 \times \sqrt{(TJC-28)} + 0.28 \times \sqrt{(SJC-28)} + 0.014 \times VAS + 0.36 \times \ln(CRP+1) + 0.96$	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	나. 평가방법 1) 동 약제를 6개월간 사용 후 평가시 DAS28 이 1.2 이상 감소한 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 2) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 6개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 다. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Abatacept, Tocilizumab 주사제, Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선	TJC(Tender Joint Count): 압통 관절수 SJC(Swollen Joint Count): 부종 관절수 VAS(Visual Analogue Scale): 환자의 전반적인 상태보고 나. 평가방법 <u>1) 6개월 투여 후 평가(최초 평가):</u> <u>DAS28 1.2 이상 감소한 경우 인정</u> <u>2) 이후 6개월마다 평가: 최초 평가결과 유지 시 인정</u> 다. 교체투여 <u>1) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함 (투여소견서 첨부)</u> <u>- 다 음 -</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.	<u>가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제:</u> <u>Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab 주사제</u> <u>나) T세포 억제제: Abatacept 주사제</u> <u>다) 인터루킨(Interleukin, IL)-6 억제제: Tocilizumab 주사제</u> <u>라) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib 경구제</u> <u>2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함</u>	
	2. 만성 중증 아토피 피부염 환자 가. 투여대상 3년 이상 증상이 지속되는 성인 만성 중증 아토피 피부염 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다만, 65세 이상 환자, 심혈관계 고위	<u>2. 만성 중증 아토피 피부염</u> <u>가. 투여대상(모두 만족)</u> <u>1) 3년 이상 증상이 지속되는 만 12세 이상인 경우</u> <u>가) 선행치료(모두 만족)</u> <u>동 약제 투약개시일 기준 6개월 이</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	험군 환자, 악성 종양 위험이 있는 환자에서는 기존 치료제(생물학적제제)에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 사용하여야 함. - 다 음 - 1) 1차 치료제로 국소치료제(중등도 이상의 코르티코스테로이드 또는 칼시뉴린 저해제)를 4주 이상 투여 하였음에도 적절히 조절되지 않고, 이후 전신 면역억제제(Cyclosporine 또는 Methotrexate)를 3개월 이상 투여하였음에도 반응(EASI(Eczema Area and Severity Index) 50%이상 감소)이 없거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우 * 동 약제 투약개시일 6개월 이내에 국소치료제 및 전신 면역억제제 투여이력이 확인되어야 함. 2) 동 약제 투여시작 전 EASI 23 이상	<u>내 다음의 국소치료제 및 전신 면역억제제 투여이력이 확인되어야 함.</u> <u>- 다 음 -</u> (1) <u>국소치료제(중등도 이상의 Corticosteroid 또는 칼시뉴린 억제제)를 4주 이상 투여하였음에도 조절되지 않는 경우</u> (2) <u>이후 전신 면역억제제(Cyclosporine 또는 MTX)를 3개월 이상 투여하였음에도 반응(EASI 50%이상 감소)이 없거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우</u> - 단, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함. 나) <u>EASI(Eczema Area and Severity Index) 23 이상</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	<추 가>	2) <u>1년 이상 증상이 지속되는 만 6세-만 11세</u> 가) <u>선행치료(모두 만족)</u> <u>동 약제 투약개시일 기준 4개월 이</u> <u>내 다음의 국소치료제 투여이력이 확</u> <u>인되어야 함.</u> -다 음- (1) <u>국소치료제(중등도 이상의 Corticosteroid 또</u> <u>는 칼시뉴린 억제제)를 4주 이상 투</u> <u>여하였음에도 조절되지 않거나 부</u> <u>작용 등으로 사용할 수 없는 경우</u> - 단, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(생물 학적 제제)에 반응하지 않거나 내약 성이 없는 경우에 한하여 동 약제 를 사용하여야 함. 나) <u>EASI(Eczema Area and Severity</u> <u>Index) 21 이상</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	나. 평가방법 1) 동 약제를 16주째 평가하여 EASI가 75%이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 2) 이후에는 지속적으로 6개월마다 평가 하여 최초 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 다. 교체투여 1) 동 약제에 효과가 없거나 부작용 등으	<u>* 임상 사진 제출 필수: EASI 점수 측정 시 중증도 판단을 위한 환부사진이 확인되어야 함.</u> <u>3) 만 2세 - 만 5세</u> <u>만성 중증 아토피피부염 환자로서 상기 2. 가.의 2)의 가), 나)의 조건을 모두 만족하는 경우</u> 나. 평가방법 <u>1) 투여 후 16주차 평가(최초 평가): EASI 75%이상 감소 시 인정</u> <u>2) 이후 6개월마다 평가: 최초 평가결과 유지 시 인정</u> 다. 교체투여 <u>1) 동 약제에 효과가 없거나 부작용 등으</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지 권고)에는 생물학적 제제(Dupilumab, Lebrikizumab, Tralokinumab 주사제)로 교체투여를 인정하며, 투여소견서를 첨부하여야 함.(다만, 65세 이상 환자, 심혈관계 고위험군 환자, 악성 종양 위험이 있는 환자의 경우는 제외) 2) JAK 억제제(Janus kinase inhibitor) 간 교체투여는 인정하지 않음. 라. 동 약제는 아토피 관련 진료과(피부과, 알레르기내과, 소아청소년과(소아알레르기호흡기)) 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, EASI 산출 근거, 환부 사진 등)를	<u>로 지속 투여가 불가능한 경우 생물학적 제제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부)</u> - 단, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우는 제외 ※ 생물학적 제제: Dupilumab, Lebrikizumab, Tralokinumab, 주사제 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. 3) 동 계열(JAK 억제제) 내 교체투여는 인정하지 않음. 라. 진료과 및 자료제출 1) 동 약제는 아토피 관련 진료과(피부과, 알레르기내과, 소아알레르기호흡기) 전문의가 처방하여야 함. 2) 상기 가. 투여대상 및 나. 평가방법 관련 객관적 자료(약제투여 과거력,	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	반드시 제출하여야 함.	<u>EASI 산출근거, 환부 사진 등)를 제출하여야 함.</u>	
	3. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함. 다만, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 60~90일분까지 인정함.	3. (현행과 같음)	
	4. 동 약제의 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항 (금기 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함.	4. (현행과 같음)	
	5. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF- α inhibitor 사용 시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	5. (현행과 같음)	

※ 관련근거

- Goodman & Gilman's: The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, 14e, 2022
- Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology, 6e, 2021
- 2024 한국 아토피피부염 치료 가이드라인. 대한아토피피부염학회

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
• 소아청소년 아토피피부염 진료지침, 2023, 대한 소아알레르기 호흡기학회 • European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I – systemic therapy, 2025. • Guidelines of care for the management of atopic dermatitis in adults with phototherapy and systemic therapies, 2023, AAD(American Academy of Dermatology). • Atopic dermatitis(eczema) guidelines: 2023 American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/American College of Allergy, Asthma and Immunology Joint Task Force on Practice Parameters GRADE-and Institute of Medicine-based recommendations. • Executive summary: Japanese guidelines for atopic dermatitis (ADGL), 2021, Japanese Society of Allergology. • Torrelo A, et al. Efficacy and safety of baricitinib in combination with topical corticosteroids in paediatric patients with moderate-to-severe atopic dermatitis with an inadequate response to topical corticosteroids: results from a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study (BREEZE-AD PEDS), Br J Dermatol, 2023. • Wollenberg A, Ikeda M, Chu CY, et al. Longer-term safety and efficacy of Baricitinib for atopic dermatitis in pediatric patients 2 to <18 years old: a randomized clinical trial of extended treatment to 3.6 years. J Dermatology Treat, 2024. • NICE(National Institute for Health and Care Excellence), Baricitinib for treating moderate to severe atopic dermatitis, 2021. • SMC(Scottish Medicines Consortium), Baricitinib, 2021.			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Belimumab 주사제 (품명: 벤리스타주 120밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 표준요법(코르티코스테로이드, 항말라 리아약, 면역억제제 단독 또는 병용투 여)으로 3개월 이상 치료 중인 자가 항체 양성인 활동성 전신홍반루푸스 만 18세이상 성인 환자로서 다음 가), 나), 다) 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) SELENA-SLEDAI* 10 이상 나) 항dsDNA항체 양성 다) 낮은 보체(C3 또는 C4) 2) 중증의 활성 중추신경계 전신홍반루푸 스, 중증의 활성 루푸스 신염 환자에	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 표준요법(코르티코스테로이드, 항말라 리아약, 면역억제제 단독 또는 병용투 여)으로 3개월 이상 치료 중인 자가 항체 양성인 활동성 전신홍반루푸스 만 18세이상 성인 환자로서 다음 가), 나), 다) 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) SELENA-SLEDAI* 10 이상 나) 항dsDNA항체 양성 다) 낮은 보체(C3 또는 C4) 2) 중증의 활성 중추신경계 전신홍반루푸 스, 중증의 활성 루푸스 신염 환자에	○ 임상진료지침, 임 상연구문헌 등을 참고하여, 최대 투 약기간을 84개월로 연장함

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	는 인정하지 아니함. 나. 투여방법 1) 최초 투약 후 24주째 평가를 통하여 SELENA-SLEDAI*가 4 이상 감소한 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 2) 이후 6개월마다 평가하여 첫 24주째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함(최대 36개월). ※ SELENA 전신성 홍반성 루푸스 활동성 지표(SELENA-SLEDAI: a Safety of Estrogen in Lupus National Assessment-Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)	는 인정하지 아니함. 나. 투여방법 1) 최초 투약 후 24주째 평가를 통하여 SELENA-SLEDAI*가 4 이상 감소한 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 2) 이후 6개월마다 평가하여 첫 24주째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함(최대 84개월). ※ SELENA 전신성 홍반성 루푸스 활동성 지표(SELENA-SLEDAI: a Safety of Estrogen in Lupus National Assessment-Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022) > Chapter 356: Systemic Lupus Erythematosus			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· EULAR recommendations (2023 update) · APLAR(The Asia-Pacific League of Assocaitions for Rheumatology consensus statements on the management of system lupus etyrhematosus (2021 update), Lancet Rheumatology 2021;3:e517-31 · Van Vollenhoven et al, Long-term safety and limited organ damage in patients with systemic lupus erythematosus treated with belimumab: a Phase III study extension, Rheumatology 2020;59:281291, doi:10.1093/rheumatology/kez279 Advance Access publication 13 July 2019 · Y. Tanaka, SC Bae et al, Long-term open-label continuation study of the safety and efficacy of belimumab for up to 7 years in patients with systemic lupus erythematosus from Japan and South Korea, RMD Open 2021;7:e001629. doi:10.1136/rmdopen-2021-001629 · Mariele Gatto et al, Early Disease and Low Baseline Damage as Predictors of Response to Belimumab in Patients With Systemic Lupus Erythematosus in a Real-Life Setting, Arthritis & Rheumatology Vol.72, No.8, August 2020, pp1,314-1,324 © 2020, American College of Rheumatology · F. Zhang, et al, Phase 3, long-term, open-label extension period of safety and efficacy of belimumab in patients with systemic lupus erythematosus in China, for up to 6 years, RMD Open 2022;8:e001669. doi:10.1136/rmdopen-2021-001669 · R. A. Furie et al, Long-Term Safety and Efficacy of Belimumab in Patients With Systemic Lupus Erythematosus, A Continuation of a Seventy-Six-Week Phase III Parent Study in the United States, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 6, June 2018, pp 868-877 · Y. Tanaka et al, Long-term safety and efficacy of belimumab in Japanese patients with SLE: A 7-year open-label continuation study, Modern Rheumatology, 00, 2021, 1-12 · Bae et al, The effect of 24-week belimumab treatment withdrawal followed by treatment restart in patients with SLE: an open-label, non-randomised 52-week study, Arthritis Research & Therapy (2022) 24:46,			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
https://doi.org/10.1186/s13075-022-02723-y · NICE>technology appraisal guidance: Belimumab for treating active autoantibody-positive systemic lupus erythematosus(December 2021) · CADTH> Drug Reimbursement Recommendation (April, 2020) · PBAC> Public Summary Document – July 2020 PBAC Meeting			

[239] 기타의 소화기관용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[239] Migalastat 경구제 (품명:	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등 을 참조하여 45kg 이 상의 12세 이상 청소년

[239] 기타의 소화기관용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
갈라폴드캡슐)	가. 투여대상 ○ 순응변이가 확인된 <u>만 16세 이상</u>의 파브리병 환자로서 다음 조건을 모두 만족하는 경우 - (생 략) - 다 음 - 1) ~ 2) (생 략) <u>3) 12개월 이상 효소대체요법을 실시한 경우 또는 효소대체요법이 불가능한 경우 (효소 억제에 대해 알려지 또는 과민반응이 있거나 효소대체요법을 위한 혈관 확보가 불가능한 경우)</u> 나. (생 략) 다. 평가방법 ○ 이 약 치료 시작 전 최초 평가를 실시하며, 이후 <u>매 6개월</u> 간격으로 신기능 검사(사구	가. 투여대상 ○ 순응변이가 확인된 <u>성인 또는 45kg 이상의 12세 이상 청소년</u>의 파브리병 환자로서 다음 조건을 모두 만족하는 경우 - (현행과 같음) - 다 음 - 1) ~ 2) (현행과 같음) <u><삭 제></u> 나. (현행과 같음) 다. 평가방법 ○ 이 약 치료 시작 전 최초 평가를 실시하며, 이후 <u>매 6-12개월</u> 간격으로 신기능 검사(사	년 환자에 급여를 확대하고, 효소대체요법 선행조건을 삭제 및 평가방법을 변경함.

[239] 기타의 소화기관용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	체여과율 <u>포함</u>), 심기능 검사(EKG <u>포함</u>), Lyso-Gb3 검사를 통해 종합적으로 평가하여 동 약제의 최초 투여 시점에 비해 질병상태가 유지되거나 개선된 경우 지속투여를 인정함. 라. (생 략)	구체여과율 <u>등</u>) 또는 심기능 검사(EKG <u>등</u>) 등을 통해 약제 투여 효과에 대해 종합적으로 평가토록 함. 라. (현행과 같음)	

※ 관련근거

1. GeneReviews@[Internet]
2. Goldman-Cecil Medicine 27e> Chapter 192: Lysosomal Storage Diseases
3. Nelson Textbook of Pediatrics 22e> Chapter 106 Defects in Metabolism of lipids
4. Interdisciplinary Guideline for the Diagnosis and Treatment of Fabry Disease. Guidelines of the German Neurological Society (2022)
5. Preventing the consequences: An evidence-driven proposal for a change in the treatment paradigm for Fabry disease to ensure timely and equitable access to treatment after confirmatory diagnosis. Fabry Australia (2022)
6. Guidelines for the treatment of Fabry Disease. British Inherited Metabolic Disease Group (2020)
7. 2020 Canadian Fabry Disease Treatment Guidelines
8. 2024 Update of the TSOC Expert Consensus of Fabry Disease. Acta Cardiol Sin 2024;40:544-68.
9. An expert consensus on practical clinical recommendations and guidance for patients with classic Fabry disease Mol Genet Metab 2022;137:49-61.
10. Consensus recommendations for the treatment and management of patients with Fabry disease on migalastat: a modified Delphi study Front. Med. 2023;10:1220637.

[239] 기타의 소화기관용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
11.	D.P. Germain et al, Treatment of Fabry’s Disease with the Pharmacologic Chaperone Migalastat, N Engl J Med 2016;375:545-55.		
12.	D.A. Hughes et al, Oral pharmacological chaperone migalastat compared with enzyme replacement therapy in Fabry disease: 18-month results from the randomised phase III ATTRACT study, J Med Genet 2017;54:288-96.		
13.	M.E .Christine et al, Safety and efficacy of recombinant human a-galactosidase a replacement therapy in fabry’s disease N Engl J Med 2001;345:9-16.		
14.	R Schiffmann et al, Enzyme Replacement Therapy. A randomized Controlled Trial, JAMA 2001;285:2743-49.		
15.	E.L. Wallace et al, Head-to-head trial of pegunigalsidase alfa versus agalsidase beta in patients with Fabry disease and deteriorating renal function: results from the 2-year randomised phase III BALANCE study, J Med Genet 2024;61:520-30.		
16.	U. Ramaswami et al, Safety and efficacy of migalastat in adolescent patients with Fabry disease: Results from ASPIRE, a phase 3b, open-label, single-arm, 12-month clinical trial, and its open-label extension, Mol Genet Metab 2025;145:109102		
17.	J.E. WRAITH et al, Safety and Efficacy of Enzyme Replacement Therapy with Agalsidase Beta: An International, Open-label Study in Pediatric Patients with Fabry Disease, J Pediatr 2008;152:563-70		
18.	M. Ries et al, Enzyme-Replacement Therapy With Agalsidase Alfa in Children With Fabry Disease, Pediatrics 2006;118:924-32.		
19.	M. Lenders et al, Treatment of Fabry’s Disease With Migalastat: Outcome From a Prospective Observational Multicenter Study (FAMOUS), Clin. Pharmacol. Ther. 2020;108:326-37.		
20.	A. Pisani et al, Clinical outcomes in patients switching from agalsidase beta to migalastat: A Fabry Registry analysis, J Inherit Metab Dis. 2024;47:1080-1095.		
21.	PBAC Public Summary Document - March 2024 PBAC Meeting, December 2022 PBAC Meeting		
22.	CADTH Canadian Drug Expert Committee Recommendation		
23.	ALBERTA BLUECROSS MIGALASTAT SPECIAL AUTHORIZATION REQUEST FORM		

[239] 기타의 소화기관용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
24. SMC migalastat, 123mg hard capsules (Galafold®) SMC No. (1196/16) (2016.10.7.)			
25. Aetna Galafold 2650-A SGM P2021Specialty Pharmacy Clinical Policy Bulletins Aetna Non-Medicare Prescription Drug Plan			
26. NICE Migalastat for treating Fabry disease (HST4)(2017.2.22.)			

[396] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[396] Empagliflozin 경구제 (품명: 자디양정 10밀리그램)	1. 제2형 당뇨병에 투여 시 [일반원칙] 당뇨병용제 “세부사항” 범위 내에서 요양급여를 인정함. 2. 허가사항 범위 내에서 상기 1. 이외에 비당 뇨 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외 에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 만성 심부전 환자(NYHA class II~IV) 1) 좌심실 박출률(LVEF: Left Ventricular	1. 제2형 당뇨병에 투여 시 [일반원칙] 당뇨병용제 “세부사항” 범위 내에서 요양급여를 인정함. 2. 허가사항 범위 내에서 상기 1. 이외에 비당 뇨 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>가. 다음에 해당하는 만성 심부전환자(NYHA class II~IV)</u> <u>(좌 동)</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임 상 논 문 , 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 비 당 뇨 성 만성신장병 환자에 급여확대

[396] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	Ejection Fraction)이 40% 이하인 환자로서 표준치료*를 안정적인 용량(stable dose)으로 투여 중인 경우 *표준치료: ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제 또는 sacubitril · valsartan을 베타차단제, aldosterone antagonist 등과 병용 2) 심부전의 증상 및 징후가 있으면서 좌심실 박출률(LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction)이 40% 초과한 환자로서 다음 중 하나를 만족하는 경우 - 다 음 - 가) 좌심실 이완기능 이상/좌심실 충만압의 증가(NT-proBNP$\geq$125pg/mL 또는 BNP$\geq$35pg/mL)에 부합하는 심장 구조 또는 기능 이상의 객관적인 증거가 있는 경우 나) 12개월 이내 심부전 악화로 응급실을 방문하였거나 입원한 경우		

[396] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	※ 동 약제는 다른 심부전 표준치료와 병용하여 투여함. <u><추 가></u> <u><추 가></u>	나. 다음을 모두 만족하는 만성 신장병 환자 <u>- 다 음 -</u> 1) ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제를 최대내약용량으로 4주 이상 안정적으로 투여 중인 경우 2) eGFR이 20 - 75ml/min/1.73m² 3) 요 시험지붕 검사(dipstick test)가 양성(1+ 이상)이거나, uACR이 200mg/g 이상인 경우 ※ 동 약제는 다른 신장병 표준치료와 병용하여 투여함.	

※ 관련근거

- National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases. Eighth Edition. © 2023 > chapter26. Pathogenesis, Pathophysiology, and Treatment of Diabetic Kidney Disease
- Goldman-Cecil Medicine. Twenty Sixth Edition © 2020 > Chapter121. Chronic Kidney Diseases

[396] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· [2022 NICE ta775] Dapagliflozin for treating chronic kidney disease · [2023 NICE ta942] Empagliflozin for treating chronic kidney disease · KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease · 만성콩팥병 임상진료지침 2022. 대한의학회, 질병관리청 · [DAPA-CKD] Hiddo J.L., et al, Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2020; 383:1436-1446. · PBS (2022.3),(2023.11) · SMC (2022.4) · [EMPA-KIDNEY] W.G. Herrington, et al, Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2023; 388:117-27.			